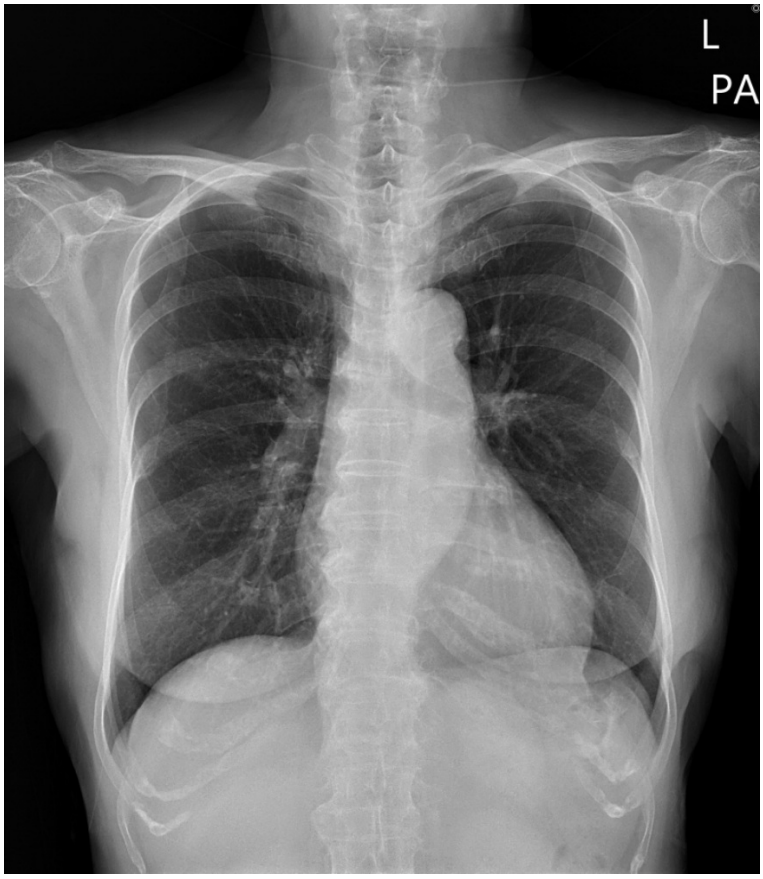
13. 피로

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 17문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 고혜진

2025년 시험 26번 · 출제자 고혜진

1. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 환자의 흉부X선 촬영 결과는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?



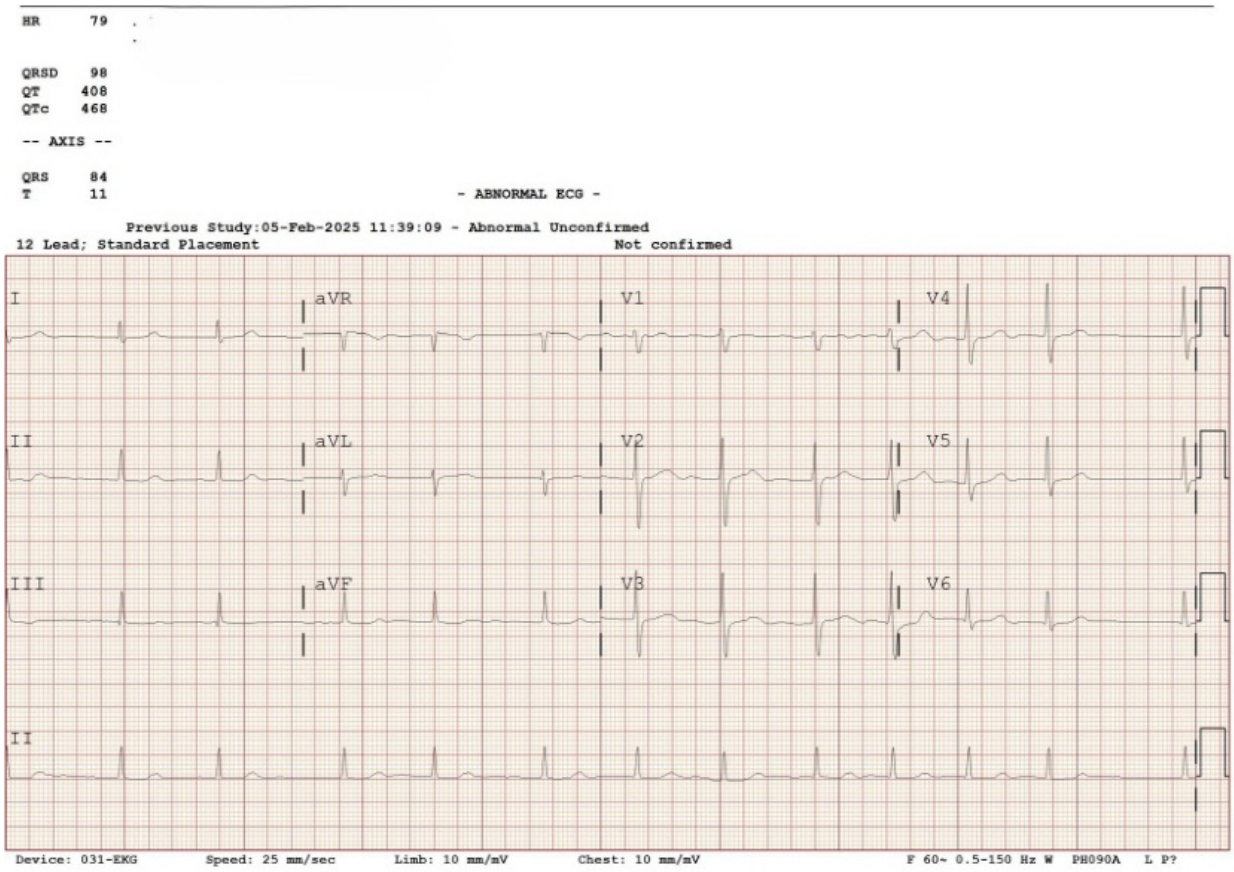
① 저나트륨혈증
② 악성질환
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ 울혈성 심부전

> **정답 ⑤**
>
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해서 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흉부 X선의 심비대 · 폐울혈은 울혈성 심부전의 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로는 심부전의 흔한 첫 증상이다. 갑상선기능저하증도 부종 · 체중 증가를 보이지만 기좌호흡 · 폐울혈은 설명하지 못한다.

2025년 시험 35번 · 출제자 고혜진

2. 46세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 평일에 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 이전에는 업무때문이라 생각했는데 최근에는 주말에 쉬는 날에도 피로감이 심하다. 체중은 수년간 서서히 증가하여 30대에는 80kg였는데 현재 90kg이다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 숨참 등의 증상은 운동을 안해서 모르겠지만 일상생활에서는 크게 못 느낀다고 한다. 의사로부터 진단받은 다른 질병은 없고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 환자의 흉부 X선 사진과 심전도는 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 우선 시행해야 할 검사는?





① HIV 항체 검사
② 수면 다원 검사
③ 자가항체검사
④ **심장초음파**
⑤ 조영증강 폐CT

> **정답 ④**
>
> 비만 · 코골이 · 주간 졸림으로 수면무호흡증을 먼저 생각하기 쉽지만, 이 환자는 과음력이 있고 흉부 X선과 심전도에서 심장 이상 소견(심비대 등)이 보이며 쉬어도 피로가 지속된다. 따라서 구조적 심장질환(알코올성 심근병증, 수면무호흡에 따른 폐고혈압 등)을 먼저 확인하기 위해 심장초음파를 가장 우선 시행한다. 수면다원검사는 그다음에 시행할 수 있다.

2025년 시험 62번 · 출제자 고혜진

3. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견이 아닌 것은?

① 발열
② 만성 기침
③ 체중감소
④ **압통성 림프절 비대**
⑤ 운동 후 권태감

> **정답 ④**
>
> 피로 환자에서 발열, 만성 기침, 체중감소, 림프절 비대(특히 단단하고 커지는 것) 같은 소견은 감염 · 악성 종양 등 기질적 질환을 시사한다. 정답은 압통이 있는 림프절 비대로, 만성피로증후군 진단 기준의 부증상(압통성 경부 · 겨드랑 림프절)에 포함되는 소견이기 때문이다.
> ※ 확인 필요: 운동 후 권태감(post-exertional malaise)도 만성피로증후군의 핵심 증상이라 기질적 질환을 시사하지 않는 소견이다(2020년 54번에서도 오답 보기로 쓰임). 출제 의도를 강의 자료로 확인하세요.

2024년 시험 22번 · 출제자 고혜진

4. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 “얼굴이 누렇게 떴다”라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?



① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 혈청 코티졸
④ 갑상선기능검사
⑤ 24시간 혈압 측정

> **정답 ①**
>
> 기립 시 어지럼증, 쉽게 피로함, 결막 창백(사진)은 빈혈을 시사한다. '얼굴이 누렇게 떴다'는 표현과 노란 손바닥도 창백함을 함께 보여 줄 수 있다. 피로의 원인으로 빈혈을 확인하기 위해 가장 먼저 전체혈구계산(CBC)을 시행하고, 이어서 원인(철결핍, 위장관 출혈 등)을 찾는다.

2024년 시험 36번 · 출제자 고혜진

5. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 6개월 동안 2kg의 체중 감소
③ **간헐적 객혈**
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

> **정답 ③**
> 간헐적 객혈은 폐결핵 · 폐암 · 기관지확장증 등 기질적 질환을 시사하는 경고 증상이다. 28세라는 젊은 나이, 6개월간 2 kg 정도의 경미한 체중 변화(5% 미만), 항불안제 복용, 비특이적인 식욕 저하는 그 자체로 기질적 질환을 강하게 시사하지 않는다.

2023년 담당 고혜진

2023년 시험 29번

6. 68세 남자가 최근 2개월전부터 지속되는 피로로 내원했다. 밤에 잠도 잘 자는데 낮에도 계속 피곤하고 자고 싶다고 한다. 이로 인해 집중하기 어려워 업무에 지장이 있다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 가능성이 높은 약제를 모두 고르시오. (2가지)

① **Gabapentin**
② Acetaminophen
③ UDCA (ursodeoxycholic acid)
④ **Chlorpheniramine**
⑤ Cholecalciferol

> **정답 ①, ④**
> 가바펜틴(항경련제 · 신경병증 통증 약)과 클로르페니라민(1세대 항히스타민제)은 중추신경계 억제 작용으로 졸림과 피로를 흔히 일으킨다. 아세트아미노펜, UDCA(우르소데옥시콜산), 콜레칼시페롤(비타민 D)은 졸림을 거의 일으키지 않는다. 피로 환자에서는 복용 약물을 반드시 확인해야 한다.

7. 48세 여자가 1년간 지속되는 피로를 주소로 내원했다. 지속되는 피로로 업무에 지장이 있다고 하며, 집중이 잘 되지 않고 머리가 멍한 느낌이다. 운동하면 좋아질까 해서 산책을 다녀온 후에는 더 피곤해서 아무 일도 못 했다고 한다. 어깨, 양쪽 무릎, 손목, 골반 등 여러 관절이 아프고 팔다리가 쑤시고 아프다며 근육통을 호소한다. 잠은 6~7시간 정도 자는데 얕은 잠을 자는 느낌이고 자고 나도 개운하지 않다. 현재 복용중인 약은 없고, 정기 검진을 받고 있는데 올해 초 검진에서 특별한 이상소견은 없었다. 기분 문제는 없다고 하며, 술이나 담배는 하지 않는다. 월경은 규칙적으로 하고 가장 최근 월경시작일은 5일 전이다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 수면무호흡증
② 심부전
③ 갑상선기능저하증
④ 부신기능부전
⑤ 만성피로증후군

정답 ⑤

6개월 이상 지속되는 설명되지 않는 피로로 일상생활이 크게 제한되고, 운동 후 악화되는 권태감(post-exertional malaise), 자도 개운하지 않은 수면, 집중력 저하(브레인 포그), 여러 관절통 · 근육통이 있으며 검진에서 이상이 없으므로 만성피로증후군(근육통성 뇌척수염)이다. 수면무호흡 · 심부전 · 갑상선기능저하 · 부신기능부전은 각각의 특징적인 소견(코골이, 부종 · 호흡곤란, 체중 증가 · 추위 민감, 저혈압 · 색소침착)이 없다.

8. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 최근 2개월 전부터 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 앉았다 일어나면 핑 도는 느낌이 들어 몇 번 쓰러질 뻔 했다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 자기가 보기에도 손바닥이 지나치게 노란 것 같다고 한다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 환자의 결막은 <사진>과 같다. 이 환자의 피로의 원인을 확인하기 위해 우선 해야 할 검사는?



① 전체혈구계산(CBC)
② 간기능검사
③ 갑상선기능검사
④ 혈청 전해질 검사
⑤ 인터페론 감마 분비 검사(Interferon-Gamma Release Assay)

> **정답 ①**
> 기립 시 어지럼증(쓰러질 뻔함), 쉽게 피로하고 운동 후 심하게 지침, 결막 창백(사진)은 빈혈을 시사한다. '얼굴이 누렇게 떴다', 노란 손바닥도 창백함을 보여 줄 수 있다. 피로의 원인으로 빈혈을 확인하기 위해 가장 먼저 전체혈구계산(CBC)을 시행하고, 이어서 원인(철결핍, 위장관 출혈 등)을 찾는다. 갑상선 · 림프절 진찰이 정상이고 결핵을 시사하는 소견도 없다.

2022년

2022년 시험 19번

9. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 운동 후 근육통
③ **설명할 수 없는 체중감소**
④ 최근 복용한 항불안제
⑤ 식욕 저하

> **정답 ③**
> 설명할 수 없는 체중감소는 악성 종양 · 감염 · 내분비 질환 등 기질적 질환을 시사하는 대표적인 경고 증상이다. 젊은 나이, 운동 후 근육통, 항불안제 복용, 식욕 저하는 그 자체로 기질적 질환을 강하게 시사하지 않는다.

2022년 시험 53번

10. 평소 건강했던 43세 여자가 최근 1년 전부터 서서히 심해지는 피로로 내원했다. 자고 일어나도 개운하지 않아 계속 누워 있다가 점심 경에 겨우 일어나서 활동한다. 운동을 하고 나면 조금 덜하지만 운동하러 나가기가 싫어서 운동은 잘 하지 않는다. 그날 컨디션에 따라 피로감은 약간 변동한다. 식사준비도 하기 싫고 입맛도 없지만 1년동안 몸무게 3kg 정도 증가했다. 잠이 오지 않아 새벽까지 뒤척이다가 짧게 선잠을 자는 느낌이고 밤에 생각이 많다. 신체진찰에서 목에 만져지는 림프절은 없고 갑상선 비대는 없었다. 결막은 창백하지 않았고 복부와 다리에 특이소견 없었다. 가장 의심되는 진단은?

① 빈혈
② **우울증**
③ 악성 종양
④ 만성 간질환
⑤ 갑상선기능 저하증

> **정답 ②**
> 1년 동안 서서히 심해진 피로에 의욕 저하(식사준비도 하기 싫음), 식욕 저하, 불면(새벽까지 잠 못 듦 · 선잠), 생각이 많음, 컨디션에 따른 변동이 있고 진찰 소견(림프절 · 갑상선 · 결막 · 부종)이 정상이므로 우울증을 가장 의심한다. 빈혈은 결막 창백, 악성 종양은 체중감소, 갑상선기능저하는 갑상선 비대 · 추위 민감 등이 있어야 한다.

2022년 시험 74번

11. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 피곤해서 자고 싶은데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ **울혈성 심부전**

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흡기 시 수포음, S3 갤럽은 울혈성 심부전의 전형적인 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로가 심부전의 첫 증상으로 나타날 수 있다. 수면무호흡 · 갑상선기능저하 · COPD로는 S3 갤럽과 폐부종을 설명할 수 없다.

2021년

2021년 시험 23번

12. 36세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 1년 전부터 항상 피로하다고 생각했으며 최근 2개월 전부터 더 심해졌다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 잠을 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 최근에 변비도 심하고 피부도 푸석푸석한 것 같다고 하며, 2개월 동안 3kg 체중 증가도 있다. 입맛도 없고 구역도 자주 있었는데도 체중이 늘고 몸도 붓는 것 같다고 한다. 예전에는 매일 배변하는 편이었으나 최근에는 주 1~2회 정도만 배변해서 변비도 동반되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 60회, 양쪽 하지에 함요부종은 없다. 갑상선 크기가 약간 커져 있으나 압통은 없다. 경부에 만져지는 림프절은 없다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 물어야 할 병력은?

① **마지막 월경 시작일**
② 호흡기 증상(기침, 가래 등) 동반 여부
③ 수면시 코골이 여부
④ 갑상선 질환의 과거력
⑤ 운동시 피로 악화 여부

> **정답 ①**
> 가임기 여성이 피로, 구역, 식욕 저하, 체중 증가, 부종, 변비를 호소하면 갑상선기능저하증과 비슷해 보여도 가장 먼저 임신 가능성을 확인해야 하므로 마지막 월경 시작일을 물어야 한다(임신은 검사 · 치료 선택에 직접 영향). 그다음 갑상선 질환 병력과 갑상선 기능검사로 갑상선기능저하증을 확인한다.

2021년 시험 45번

13. 기질적인 질환임을 시사하는 경고 증상이나 징후가 아닌 것은?

① **수년간 지속된 피로**
② 체중감소
③ 호흡곤란
④ 부종
⑤ 폐경 후 질출혈 재개

> **정답 ①**
> 체중감소, 호흡곤란, 부종, 폐경 후 다시 생긴 질출혈은 모두 기질적 질환(악성 종양 · 심부전 등)을 시사하는 경고 증상이다. 수년간 비슷하게 지속된 피로는 오히려 기능성 피로(만성피로 등)일 가능성을 시사하며, 최근에 시작되었거나 빠르게 악화되는 피로가 기질적 원인을 더 시사한다.

2021년 시험 61번

14. 74세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 항상 피로했는데 최근 2~3개월 전부터는 피로감이 더 심해졌고 조금만 활동하려고 해도 힘들어서 활동량이 줄었다. 이전에 비해 쉽게 숨도 차고 가슴도 답답한 것 같다. 잠을 푹 자고 나면 덜한데 자려고 누우면 더 답답해서 자다가 자꾸 깬다. 식사량이 더 늘지는 않았는데 몸무게가 2kg 정도 늘었다. 고혈압약, 고지혈증약 복용 중이고 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 신체진찰 결과 혈압 160/70 mmHg, 맥박 68회/분, 결막은 약간 창백하고 양쪽 하지에 함요부종이 확인된다. 폐진찰시 흡기시 수포음(rale), 심장 진찰시 심음은 규칙적이나 S3 gallop이 의심된다. 이 환자의 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 저나트륨혈증
② 수면무호흡증
③ 갑상선기능저하증
④ 만성폐쇄성폐질환
⑤ **울혈성 심부전**

> **정답 ⑤**
> 활동 시 호흡곤란, 누우면 답답해 깨는 기좌호흡, 체중 증가, 양측 함요부종, 흡기 시 수포음, S3 갤럽은 울혈성 심부전의 전형적인 소견이다. 고령 고혈압 환자에서 피로가 심부전의 첫 증상으로 나타날 수 있다. 수면무호흡 · 갑상선기능저하 · COPD로는 S3 갤럽과 폐부종을 설명할 수 없다.

2020년

2020년 시험 54번

15. 피로를 호소하는 환자에서 기질적 질환임을 시사하는 소견은?

① 나이 28세
② 근육통
③ **체중감소**
④ 업무량 과다
⑤ 운동 후 권태감

> **정답 ③**
> 체중감소는 악성 종양 · 감염 · 내분비 질환 등 기질적 질환을 시사하는 대표적인 경고 증상이다. 젊은 나이, 근육통, 업무량 과다, 운동 후 권태감은 기능성 피로(과로, 만성피로증후군 등)에서 흔한 소견이다.

2020년 시험 55번

16. 50세 남자가 피로로 내원했다. 수년전부터 피로하고 요즘엔 더 피곤하다. 회사원으로 팀장을 맡고 있어 업무량이 매우 많다. 아침에는 버티고 있는데 오후가 되면 저절로 눈이 감긴다. 너무 피곤해서 커피를 계속 마시면서 버티고 있다. 체중변화는 없고 피로 외 다른 증상은 없다. 본인 말로는 기절하듯이 쓰러져 자고 잠은 잘 자는데, 코골이가 심해 아내와 다른 방에서 잔다. 1년전 검진에는 고혈압 전단계 외 특별한 이상소견 없었고, 처방받아 복용 중인 약물은 없다. 술은 주 3-4회, 회당 소주 2-3병 마시고 키 177 cm, 몸무게 90 kg이다. 이 환자의 피로의 원인을 진단하기 위해 가장 우선 해야 할 검사는?

① HIV 항체 검사
② **수면 다원 검사**
③ 전혈구 계산(CBC)
④ 흉부 X선 검사
⑤ 갑상선 기능 검사

> **정답 ②**
> 비만(BMI 약 29), 심한 코골이, 잠은 충분히 자는데도 낮에 저절로 눈이 감길 정도의 주간 졸림, 음주력은 폐쇄성 수면무호흡증을 강하게 시사한다. 확진을 위해 가장 우선 시행할 검사는 수면다원검사다. 다른 증상이 없어 HIV · CBC · 흉부 X선 · 갑상선 기능검사는 우선순위가 낮다.

17. 66세 여자가 피로를 주소로 내원하였다. 이전부터 쉽게 피로하다고 생각했는데 최근 2개월 전부터 너무 심하게 피로하다고 한다. 아침에 일어나도 개운하지 않고 피로하며, 하루 종일 피곤하다. 가끔 억지로 운동이라도 하고 나면 너무 피로해서 꼼짝도 못하겠고 바로 누워 자고 싶다. 잠은 잘 자기는 하는데 자도 개운하지 않고 몸이 무겁다. 주변에서 "얼굴이 누렇게 떴다"라고 하는데 본인이 생각하기에 화장을 안해서 그렇다고 생각했다. 변비는 없는데 최근 변이 무르고 짜장같은 색의 변을 자주 본다. 요즘 입맛도 없고 식사량도 조금 줄었으며 2개월 동안 4kg 체중 감소되었다. 가정주부로 최근 더 심한 스트레스는 없고, 다른 약물 복용력도 없다. 고혈압이나 당뇨병 없으며 그 외 의사로부터 진단받은 질병은 없다. 술은 마시지 않고, 담배는 피지 않는다. 신체진찰 결과 체온 36.3도, 혈압 100/80 mmHg, 맥박 분당 90회였고 결막이 창백하다. 갑상선 크기 정상이고 만져지는 결절은 없다. 피로의 원인으로 가장 의심되는 진단은?

① 우울증
② 간경화증
③ **악성 종양**
④ 만성 신부전
⑤ 갑상선 기능 저하증

> **정답 ③**
> 고령 여성에서 2개월간 진행한 심한 피로, 4 kg 체중감소, 식욕 저하, 짜장 같은 색의 무른 변(흑색변, 상부위장관 출혈), 결막 창백(빈혈)은 위장관 악성 종양(위암 등)에 의한 출혈과 빈혈을 시사한다. 우울증 · 갑상선기능저하증은 흑색변과 빈혈을 설명하지 못하며, 간경화 · 만성 신부전도 이 경과와 맞지 않는다.